武汉养老机构精准匹配小程序

MVP 页面方案 V1.1 · 问卷与机构资料扩展修订版 · 2026-09-04

本次 MVP 修订重点

- 健康页加入咀嚼/吞咽，不把进食困难直接等同鼻饲
- 偏好页增加房型、膳食、活动，并重构最多 3 项关注因素
- 机构详情新增护理团队、医疗值守、健康检测、膳食、活动、交通与收费拆分
- 推荐结果由“固定 3 家”改为“最多 3 家”，护理硬冲突不为凑卡放宽
- 所有新增机构字段必须可核验；未知显示待核验/暂未提供

01 首页

/pages/home/index

页面目标

解释产品用途、引导开始评估，并建立“武汉本地精选机构 + VR + 顾问服务”的第一层信任。

首屏 Hero

主标题先了解老人情况，再找到更合适的养老机构

- 副标题：根据身体情况、照护需求、生活偏好和预算，从武汉合作养老机构中为您筛选。
- 主按钮：开始养老需求评估 → 评估说明
- 次按钮：查看合作机构 → 合作机构列表

首页内容模块

- 品牌区：小程序名称 + “武汉本地养老机构匹配服务”，不设置城市切换。
- 核心优势：精准评估 / 武汉精选 / VR 看院 / 顾问协助。
- 快速需求：医养结合 / 失能护理 / 认知症照护 / 康复养老 / 品质养老。
- 精选机构：仅展示 3 家，卡片包含图片、名称、区域、类型、参考月费、2-3 个标签与 VR 标识。
- 二次评估 CTA：“不知道该怎么选？3-5 分钟完成评估。”
- 顾问入口：说明可协助护理等级、费用、机构差异和看院安排。

首页克制原则不要做养老资讯门户；不要堆政策文章；不要让用户先搜索几十个条件。首页只完成“理解 - 评估 - 看机构”三件事。

02 评估说明

/pages/assessment/intro

页面目标

降低问卷心理压力，让用户知道要填什么、为什么填、需要多久。

页面主文案

标题

全面了解老人情况，推荐才更准确

- 说明：从健康情况、生活自理能力、认知状态、养老需求和预算等方面了解老人。
- 步骤概览：基本情况 / 身体与生活能力 / 认知与护理需求 / 养老偏好 / 预算与入住计划。
- 提示：预计 3-5 分钟；不清楚可选“暂不确定”；信息仅用于养老需求评估和机构匹配。

底部操作

- 主按钮：开始评估 → 基本情况。

03 老人基本情况

/pages/assessment/basic

页面目标

建立老人基础档案，为后续健康评估、推荐和历史记录建立归属。

老人与您的关系

父亲 母亲 配偶

祖父 祖母 外祖父

外祖母 本人 其他

老人姓名

选填，仅用于家庭档案识别。

性别

- 男
- 女

年龄数字输入或滚轮选择，建议范围 50-110。

目前居住状态

独居 与配偶同住 与子女同住

与其他亲属同住 当前住院 已入住养老机构

其他

主要照护者

配偶 子女 保姆

护工 社区照护 暂无固定照护者

其他

是否有养老机构入住经历

- 有
- 没有

条件展开

- 若选择“有”，显示离开上一家机构的主要原因：护理、服务态度、收费、距离、医疗、环境、饮食、老人不适

应、其他。

04 健康情况

/pages/assessment/health

> 页面目标：了解老人的基础疾病、近期健康风险、康复需求，以及影响养老机构膳食与进食照护的咀嚼/吞咽情况。

第2步/共6步

字段 1：目前是否存在以下疾病（多选）

- 高血压
- 糖尿病
- 冠心病
- 脑卒中后遗症
- 帕金森
- 阿尔茨海默症
- 其他认知障碍
- 慢性呼吸疾病
- 骨关节疾病
- 肿瘤
- 其他慢性疾病
- 暂无明显慢性疾病
- 暂不清楚

互斥：选择“暂无明显慢性疾病”或“暂不清楚”时，不与其他具体疾病并存。

字段 2：近期是否发生以下情况（多选）

- 近半年发生过跌倒
- 近半年发生过骨折
- 近半年频繁住院
- 近期刚出院
- 术后恢复中
- 长期卧床
- 存在压疮
- 以上均无
- 暂不清楚

字段 3：是否有康复需求（单选）

- 明确需要
- 可能需要
- 不需要
- 不确定

字段 4：老人目前的咀嚼情况如何（单选，新增）

- 正常咀嚼
- 更适合软食、易咀嚼食物
- 咀嚼能力较差，需要对食物做特殊处理
- 暂不确定

字段 5：老人目前的吞咽情况如何（单选，新增）

- 正常
- 偶尔吞咽不顺或容易呛咳
- 明显吞咽困难
- 暂不确定

业务边界
咀嚼困难或吞咽困难只表示饮食形式/进食照护可能需要进一步确认，不自动等于鼻饲需求。只有“鼻饲护理”被明确选择时，才形成对应的特殊护理需求。

上一步　　下一步 → 页面 05

05 日常生活能力

/pages/assessment/adl

> 页面目标：通过具体生活场景判断老人照护强度，不让家属自行理解专业“失能等级”。

第3步/共6步

项目	选项
进食能力	完全独立 / 少量协助 / 需要喂饭 / 鼻饲或其他特殊进食方式
行走能力	独立行走 / 助行器 / 轮椅 / 基本无法下床
如厕能力	独立 / 偶尔协助 / 经常失禁 / 完全照护 / 导尿或造瘘
洗澡能力	自主 / 部分协助 / 完全协助
穿衣能力	自主 / 部分协助 / 完全协助
床椅转移	自主 / 少量帮助 / 需要搀扶 / 完全依赖
上下楼	独立 / 需要帮助 / 无法完成 / 当前无楼梯场景

后台结果

根据冻结的 ADL 规则形成“自理 / 轻度照护 / 半失能 / 失能 / 重度失能”画像标签。问卷阶段不要求用户自行判断等级。

进食字段解释
ADL 的“进食能力”回答“能否自主完成进食”；健康页新增的“咀嚼/吞咽”回答“吃什么形式、吞咽是否顺畅”。“特殊进食方式”是需要确认的照护线索，不自动推导为鼻饲。

上一步　　下一步 → 页面 06

06 认知与特殊护理

/pages/assessment/cognitive

> 页面目标：判断老人是否存在认知风险，以及是否有需要机构明确支持的特殊护理需求。

第4步/共6步

模块 A：认知与精神状态（多选）

- 记忆力明显下降
- 经常重复询问相同问题
- 容易迷路
- 有走失风险
- 昼夜作息混乱
- 情绪波动明显
- 容易躁动
- 有攻击行为
- 已确诊认知症
- 无以上情况
- 暂不确定

模块 B：特殊护理需求（多选）

- 需要 24 小时照护
- 需要一对一护工
- 需要夜间重点照护
- 需要认知症专区
- 需要康复训练
- 鼻饲护理
- 导尿护理
- 压疮护理
- 失禁护理
- 其他
- 暂不确定

新增澄清逻辑
若健康页出现“明显吞咽困难”，但未明确选择“鼻饲护理”，画像应显示“吞咽情况需进一步确认”，不得自动形成鼻饲硬条件；“导尿/造瘘”同样不自动等于“导尿护理”需求。

上一步　　下一步 → 页面 07

07 养老需求与偏好

/pages/assessment/preference

> 页面目标：了解家庭主观偏好，用于护理安全条件满足后的生活适配、偏好排序和推荐理由解释。

第5步/共6步

字段 1：更希望选择哪类养老方式（单选）

选项	人话解释
活力型养老	适合生活基本自理、重视生活品质的老人
医养结合	更重视医疗、护理与慢病管理
失能护理	适合半失能、失能老人
认知症照护	适合认知障碍老人
康复养老	适合术后、慢病或功能恢复老人
不确定	让系统根据老人情况判断

字段 2：希望老人入住什么房型（单选，新增）

- 不限制
- 单人间
- 双人间
- 三人及以上

房型属于生活偏好，不作为护理安全硬条件。

字段 3：对日常膳食安排有要求吗（单选，新增）

- 不特别要求
- 三餐
- 三餐一点
- 三餐两点

“易咀嚼/特殊处理饮食”由健康页咀嚼、吞咽情况形成适配提示，不要求用户在偏好页重复选择。

字段 4：老人平时是否重视活动和社交（单选，新增）

- 不特别在意
- 比较在意室内活动

- 比较在意户外活动
- 室内外活动都比较重要

字段 5：选择机构时最关注什么（最多 3 项，重构）

- 护理能力
- 护理人员质量
- 医疗条件
- 康复条件
- 膳食质量
- 居住环境
- 房间设施
- 活动空间
- 交通便利
- 靠近大型医院
- 价格预算
- 地理位置

删除过于笼统或与硬护理重复的“整体品质、认知症照护能力”等表述；认知症接收、鼻饲、导尿等明确护理需求由前面问卷形成硬条件，不靠主观“关注项”决定。

字段 6：希望所在区域

- 不限制
- 仅展示当前已核验合作机构实际存在的区域

区域候选由机构数据动态生成，不维护武汉全量行政区作为静态问卷选项。

上一步　　下一步 → 页面 08

08 预算与入住计划

/pages/assessment/budget

> 页面目标：判断家庭支付能力和入住意向，同时在高照护需求与较低预算组合下进行友好提醒。

第6步/共6步

字段 1：预计每月可以接受的费用（单选）

- 3500-5000 元
- 5000-8000 元
- 8000-12000 元
- 12000-15000 元
- 15000 元以上
- 暂不确定

字段 2：对押金或一次性费用的接受程度

- 可以接受
- 视具体金额而定
- 不希望存在较高一次性费用
- 不清楚

字段 3：预计入住时间

- 希望尽快入住
- 1 个月以内
- 1-3 个月
- 3 个月以后
- 目前只是提前了解

字段 4：是否希望养老顾问后续协助

- 希望顾问联系我
- 先看推荐结果

新增提醒逻辑

当老人画像显示失能/重度失能，或明确存在一对一、鼻饲、压疮、24 小时照护等高强度照护需求，同时预算较低时，可提示“实际费用可能受护理等级、特殊护理和房型影响，建议预留预算空间”。提醒不阻止继续，也不得凭空给出武汉市场最低价。

本页仍不立即索取手机号；手机号仅在用户实际预约或明确要求顾问联系时授权获取。

上一步　　查看老人需求画像 → 页面 09

09 老人需求画像确认

/pages/assessment/profile

> 让用户确认系统是否正确理解老人，并在进入推荐前建立“被理解”的感觉。

建议模块

- 老人基本标签：关系、年龄、照护等级、行动方式
- 健康状态：疾病、近期风险、康复需求
- 进食与饮食：咀嚼、吞咽及待确认特殊进食线索
- 日常照护：进食、行走、如厕、洗澡、转移
- 认知与特殊护理
- 养老偏好：类型、房型、膳食、活动、最关注 3 项、区域
- 预算与入住计划

未知或需要确认的内容必须明确显示，不把“吞咽困难”写成“鼻饲”、不把“导尿/造瘘”写成“需要导尿护理”。

每个模块提供“修改”入口；主按钮：生成机构推荐。

10 评估结果与机构推荐

/pages/recommendation/result

> 先告诉用户“老人更需要什么”，再从合作机构中给出 1-3 家可解释的选择及理由。

结果结构

- 综合建议：展示已确认的护理与生活适配重点
- 推荐原因：来自结构化老人画像与已核验机构事实
- 看院建议：护理员配置、夜间巡查、膳食、康复收费、无障碍、医疗急救等
- 推荐机构：最多 3 家，不强行凑满

推荐卡必须包含

- 机构名称、区域、机构类型
- 参考总费用区间或起价
- 1-3 个真实服务/设施标签
- 为什么推荐
- 主要差异或“需机构评估”事项
- 床位状态仅作为咨询提示
- 仅真实可用时显示 VR

禁止以“92% 匹配度”作为核心表达。护理硬冲突不能被价格、区域、环境等软偏好抵消。

11 合作机构列表

/pages/institution/index

> 展示全部约 7-8 家合作机构；完成评估后可按已冻结的推荐语义优先排序。

- 顶部标题：武汉合作养老机构
- 筛选：区域 / 类型 / 预算 / 服务能力
- 可扩展的生活适配筛选：房型、膳食、康复（仅有真实结构化数据时）
- 排序：为我推荐 / 综合 / 价格；第一版不强制距离排序

机构卡

- 真实图片或中性占位
- 名称、区域、类型、参考月费
- 核心服务标签
- 有真实 VR 才显示 VR
- 有评估时显示 1-2 条结构化“适合您的原因”

机构池只有 7-8 家，不把有限机构包装成海量搜索平台。

12 机构详情

/pages/institution/detail

> 完成“了解 → 信任 → VR → 咨询 → 预约”的核心转化，并让机构资料与新版问卷形成可解释对应。

页面信息顺序

- 封面与基础信息
- 为什么推荐给您
- VR 空间预览（真实可用时）
- 实景图集
- 适合哪些老人 / 特殊护理能力
- 日常护理与护理团队
- 医疗与康复
- 房型与适老设施
- 膳食与活动空间
- 交通区位
- 收费
- 资质
- 真实评价（有数据再上）

基础信息

- 名称、标签、武汉具体地址
- 参考总费用
- 床位状态：有床位 / 少量床位 / 需咨询 / 资料待核验
- 营业/养老服务资质与床位数（真实核验后展示）

护理能力

- 五档照护等级：自理 / 轻度照护 / 半失能 / 失能 / 重度失能
- 轮椅、卧床、转移支持
- 认知症接收、走失支持、认知症专区
- 24 小时、一对一、夜间、康复、鼻饲、导尿、压疮、失禁

能力状态统一表达“支持 / 需评估 / 暂不支持 / 资料待核验”，unknown 不等于 unsupported。

护理团队与医疗

- 护理员人数、持证、从业经验、配置比例、响应时间（有真实数据再显示）
- 医生/护士数量、护士站/医务室、24 小时值守

- 自有医院/合作医院/社区卫生服务中心
- 血压/血氧/按需血糖等日常检测
- 距离大型医院的可核验距离

房型、膳食与活动

- 单人间 / 双人间 / 三人及以上
- 独卫、空调、衣柜、电视、呼叫系统、电动窗帘、小冰箱、无障碍等真实配置
- 三餐 / 三餐一点 / 三餐两点；易咀嚼/软食能力
- 室内/室外活动空间，棋牌、书画手工、音乐、健身等真实活动

房型与收费

- 参考房费
- 床位费 + 护理费 + 餐食费 + 特殊护理费 + 押金/一次性费用
- 参考总费用为区间或起价，最终费用取决于照护等级、房型与特殊服务

数据真实性
机构未提供明确人数、比例、资质、价格、护理能力、图片或 VR 时不虚构。宁可显示“暂未提供/请咨询/资料待核验”。

13 VR 看院

/pages/institution/vr

页面目标

让用户在预约前直观看真实空间，降低环境不确定性。

- 顶部：机构名称。
- 中间：全屏或大面积 VR 全景 Viewer。
- 场景切换：外景 / 大厅 / 老人房间 / 卫生间 / 餐厅 / 康复区 / 活动区 / 花园。
- 底部固定：咨询这个机构 / 预约实地参观。

MVP 范围

第一版只做“全景浏览 + 场景切换”。护理床、扶手、呼叫器等 VR 热点交互可以放到后续版本。

机构详情中的 VR 入口

- 使用大图缩略预览，不要只放一个小图标。
- 文案：“足不出户，先在线逛一遍”。
- 明确可查看房间、大厅、餐厅、康复区及公共活动空间。

机构详情内容规范这部分不拆独立页面，全部作为机构详情的连续模块。

实景图集

- 分类：外景 / 大厅 / 房间 / 餐厅 / 卫生间 / 康复 / 活动区域 / 户外空间。
- 点击进入图片浏览。即使有 VR，也必须保留普通图片。

护理能力

- 老人类型：自理 / 半失能 / 失能 / 重度失能 / 认知症。
- 状态统一使用：支持 / 需评估 / 暂不支持。
- 特殊护理：轮椅、卧床、失禁、鼻饲、导尿、压疮、夜间照护、认知症照护。

医疗与康复

- 护士 / 医生巡诊 / 护士站 / 合作医院 / 紧急送医。
- 康复治疗师 / 康复室 / 术后康复 / 肢体功能训练 / 认知训练。

房型与收费

- 房型卡：图片、面积、床型、独立卫生间、空调、衣柜、电视、呼叫设备、阳台、无障碍设施、参考房费。
- 收费拆分：床位费 + 护理费 + 餐饮费 + 管理费 + 特殊护理费 + 押金。
- 突出“参考总费用”，并说明最终费用取决于护理等级、房型和特殊服务。

数据真实性

机构未提供明确人数、比例、资质、价格或服务能力时，不虚构数字。宁可显示“暂未提供相关资料”或“请咨询”。

14 养老顾问主页

/pages/consultant/index

页面目标

承接用户不确定、不理解或需要线下协调的场景，并把人工服务放到关键决策链路中。

顶部文案

有些养老选择，和专业顾问聊一聊更清楚

顾问能帮助

- 解读老人画像
- 推荐合作机构
- 分析机构区别
- 解读收费
- 安排看院
- 跟进入住

顾问卡片

- 头像、姓名、身份“养老顾问”、服务区域“武汉”。
- 擅长方向：医养结合 / 失能养老 / 认知症 / 品质养老等。
- 在线咨询 / 电话联系 / 请顾问帮我推荐。

MVP 简化如果当前只有 1-3 位顾问，不做复杂顾问列表和排序。只有真实可核验数据时，才展示从业年限、已服务家庭数等。

15 预约看院

/pages/appointment/create

页面目标

把线上兴趣转换成真实可跟进线索。

表单字段

- 顶部机构卡：图片、名称、地址。
- 选择老人：已有档案直接选择；无档案支持新增。
- 预约日期：日历。
- 希望时间：上午 / 下午 / 由顾问协调。
- 参观人数：1 / 2 / 3 / 4 人及以上。
- 是否需要接送：仅机构真实支持时显示。
- 联系人姓名。
- 手机号：此处再使用微信手机号授权，必填。
- 备注：例如“老人目前住院，希望重点了解康复服务”。

隐私确认

提交前提示我已阅读并同意隐私政策，并授权平台使用老人相关信息完成养老需求评估、机构匹配与服务对接。

主按钮：提交预约

16 预约成功

/pages/appointment/success

页面目标

明确告诉用户预约只是“已提交”，并提供下一步联系和查看入口。

成功文案

预约申请已提交养老顾问会进一步确认机构接待时间，并与您联系。

- 展示机构名称、日期、时间、人数。
- 主按钮：联系养老顾问。
- 次操作：查看我的预约 / 返回首页。

状态表达不要把“提交申请”写成“预约成功已确认”。机构接待时间仍需顾问确认时，状态应为“待确认”。

17 我的

/pages/mine/index

页面目标

> **管理老人档案、历史评估和看院预约。**

登录前

- 默认头像 + “登录后查看养老档案和预约”。
- 微信快捷登录。

登录后

- 微信头像、昵称。
- 老人档案卡：关系、年龄、核心标签、最近评估时间。
- 核心菜单：老人档案 / 我的评估 / 我的预约。
- 其他：联系客服 / 意见反馈 / 用户协议 / 隐私政策。

第二阶段再增加我的推荐 / 我的收藏 / 我的顾问。第一版不要因为“个人中心看起来空”而提前扩张功能。

18 老人档案

`/pages/elder/index · /pages/elder/detail`

页面目标

支持一个家庭管理多个老人，并作为后续重新评估和预约的基础对象。

- 列表卡：关系、年龄、核心照护标签、查看详情。
- 支持“添加老人”。
- 详情展示：基本信息 / 健康情况 / 生活能力 / 认知 / 特殊护理 / 养老偏好 / 预算 / 最近评估时间。
- 主要操作：重新评估 / 编辑基础档案。

数据规则重新评估不能直接覆盖旧结果。每次重新评估生成新的 Assessment，历史结果保留。

19 我的评估

/pages/assessment/history

页面目标

让用户查看历史评估结果并发起重新评估。

评估卡示例

父亲养老需求评估

2026-08-21

建议：医养结合型养老机构

操作：查看结果 | 重新评估

- 按照时间倒序排列。
- 每条评估绑定 Elder + Assessment。
- 查看结果进入当次评估的推荐结果，不动态替换为最新评估。

20 我的预约

/pages/appointment/index

页面目标

集中查看实地看院申请的状态与后续操作。

状态筛选

全部 待确认

已确认 已完成

已取消

预约卡字段

- 机构名称
- 日期与时间
- 老人
- 顾问（如已分配）
- 状态
- 联系顾问 / 查看机构 / 取消预约（按状态显示）

状态是业务事实前端不能自己推断“已确认”。状态应以后端 / 顾问运营侧为准。

必须覆盖的公共状态这些不是独立业务页面，但决定 MVP 是否真的可用。

1. 空状态

- 无老人档案：“还没有建立老人档案，完成一次养老需求评估后档案会自动生成。” → 开始评估。
- 无评估：“还没有养老需求评估。” → 开始第一次评估。
- 无预约：“暂时没有看院预约。” → 看看推荐机构。

2. 没有完全匹配的机构

推荐文案暂时没有完全符合条件的合作机构。当前合作机构中，暂时没有同时满足全部护理、预算和区域要求的机构。

- 继续显示 1-3 家“最接近您需求”的机构。
- 明确差异，例如“护理需求匹配，但预算略高约 800 元”。
- 操作：调整需求 / 让顾问帮我找。

3. 微信登录与授权

- 匿名允许：首页、机构列表、机构详情、图片、VR、填写评估。
- 需要登录：保存评估、保存档案、预约、查看历史、收藏（如做）、顾问需要联系。
- 不要进入小程序立即强制登录。
- 不要在登录时强制获取手机号。

MVP 开发范围与优先级第一版只围绕闭环投入，不把 P1/P2 功能混进主开发里程碑。

级别 范围 建议

P0 20 个业务页面 + 空状态 + 登录授权 + 必须完成并串通真实数据无完全匹配状态

P1 收藏、我的推荐、真实评价、顾问详 核心链路稳定后补情、机构轻量筛选增强

P2 全国城市、复杂地图、政策资讯、AI 当前不投入顾问、复杂横向比较、社区、商城

最值得优先打磨的 5 个页面1. 问卷：要像“被引导完成”而不是“填写表格”。

2. 老人画像：让用户第一次感到系统真正理解老人。

3. 推荐结果：告诉用户该找什么，以及为什么这几家更合适。

4. 机构详情：用真实信息、VR、费用与护理能力建立信任。

5. VR + 预约：把线上信任转成实地看院。

最终产品体验目标

用户最终只需要感觉自己做了四件事

1. 告诉平台老人现在是什么情况。2. 平台帮我判断应该找什么类型的养老机构。3. 从武汉合作机构中告诉我哪几家更合适，以及为什么。4. 通过图片和 VR 看环境，有问题问顾问，满意后预约去现场看。

MVP 成功标准

- 问卷能顺畅完成且答案可保存。
- 老人画像和推荐理由能与问卷答案对应。
- 推荐结果只来自真实合作机构数据。
- 机构详情信息完整、真实，VR 可访问。
- 顾问入口在关键页面始终可见。
- 预约信息可以真实落库并被运营侧跟进。

一句话结论

第一版的核心不是“做一个养老平台”，而是把“评估 → 解释 → 推荐 → 信任 → 预约”这一条链路做到足够顺。依据：现有《武汉养老机构精准匹配小程序 V1 页面级 PRD》及本轮 MVP 页面收敛方案。